

Zahnärztliches Universitäts-Institut (Carolinum)
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der J. W. Goethe Universität
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie
Direktor: Prof. Dr. F. Schwarz

HÄMATOLOGISCHE ERKRANKUNGEN

Dr. Amira Begic und Dr. Paula Liersch

1

Lernziele

25.5.1.2 Patientinnen/Patienten über diese Zusammenhänge adäquat aufklären und bezüglich der individuell erforderlichen Maßnahmen beraten.

25.6.1.2 Interaktionen zwischen oralen Erkrankungen und Allgemeinerkrankungen/-zuständen adäquat bewerten und mit den Patientinnen/Patienten im individuellen Kontext und situativ besprechen.

25.7.1.2 Erkennen, wann eine Konsultation mit den behandelnden Allgemein- oder Fach-Ärztinnen/-Ärzten erforderlich ist, und erforderliche Informationen zu erfragen.

25.1.1.7 Befunde im Rahmen der allgemeinmedizinischen Routinediagnostik bewerten und ihren Einfluss auf orale Erkrankungen oder deren Therapie einschätzen.

2



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

3

orale Symptome von Leukämien



Quelle: Zahnärztliche Risikopatienten, J.T. Lamrecht, M. von Planta

Gingiva-Sugillationen vestibulär mit spontanen Sulkusblutungen bei AML

Quelle: Zahnärztliche Risikopatienten, J.T. Lamrecht, M. von Planta

Palatinale Gingiva-Sugillationen bei einem Patienten mit CML

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

4

Orale Manifestationen hämatologischer Erkrankungen

- Leukämie
 - orales Frühsymptom: Gingivaschwellung, Blutungen, Ulzera
 - Subgruppen (AML, ALL, CML, CLL)
 - Fallbeispiel AML
- Multiples Myelom
 - Fallbeispiel
- Neutropenie
 - orales Frühsymptom: Erytheme, Schwellung, Infiltrate, Schmerz, Ulzerationen
 - Fallbeispiel chronische Neutropenie
- Graft-versus-Host-Disease
 - orales Frühsymptom: lichenoid Veränderungen, Hyposalivation
 - nach Stammzell- oder Knochenmarktransplantation
 - Fallbeispiel

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

5

Leukämien

- Leukämien
 - Akute Leukämien:
 - akute myeloische Leukämie (AML)
 - akute lymphatische Leukämie (ALL)
 - Chronische Leukämien:
 - chronische myeloische Leukämie (CML)
 - chronische lymphatische Leukämie (CLL)

→ Näheres hierzu folgt in der Lehrveranstaltung Innere Medizin

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

6

Erkrankung	Ursprung	Klinik	Blutbild	Erkrankungsepifel
AML	Unreife B- oder T-Zellen	Blutungszeichen Petechien Ekchymosen Infektnigung Gingivahyperplasie	Anämie, Neutropenie, Thrombozytopenie, myeloische Blasten (z. T. mit Auer- Stäbchen), Hiatus leukämicus	Erwachsene
ALL	Unreife myeloische Vorläuferzellen	Knochenschmerzen CNS Befall Infektnigung	Anämie, Thrombozytopenie, Leukozytose (variabel), lymphatische Blasten, Hiatus leukämicus	Kindesalter
CML	Pluripotente hämatopoetische Stammzellen	Immunkompetent schleichender Beginn Splenomegalie Hyperviskosität (Priapismus)	Leukozytose mit Linksverschiebung (alle myeloische Vorstufen), Basophilie	Erwachsene (20-50 Jahre)
CLL	Reife B- oder T-Zellen	Asymptomatisch Lymphknotenschwellung Hepato-Splenomegalie	Leukozytose, Vermehrung von reifen Lymphozyten, Anämie, Thrombozytopenie (20%)	Erwachsen (steigende Inzidenz mit dem Alter)

Quelle: Schmalzer, J. (Hrsg.) (2019). Zahnärztliche Praxis (12. Aufl.). Elsevier, S. 111-112 (modifiziert)

7

orale Symptome von Leukämien

- Klinik intraoral:
 - Akute, generalisierte ödematöse Gingivahyperplasie
 - Verblässung der Schleimhaut
 - Petechien
 - Ekchymosen an Gingiva, Lippen, Gaumen, Zunge
 - Nekrosen
 - Ulzerationen
- Symptomatik:
 - Schmerzhaft, entzündete und leicht blutende Gingiva
 - z.T. Spontanblutungen
- Risiko:
 - Abhängig von Leukämieart
 - Erhöhte Anfälligkeit auf mykotische, bakterielle und virale Superinfektionen

8

Fallvorstellung 1

9

Erstvorstellung

- 65-jähriger, männlicher Patient vorstellig
- Überweisung vom HZA:
 - Persistierende Gingivawucherung seit mehreren Wochen
 - Vorbehandlung: Subgingivale Instrumentierung + systemische Antibiotikagabe
- Anamnese:
 - Bluthochdruck
 - Beta-Blocker (Bisoprolol) wird seit acht Jahren eingenommen
 - Pat. gibt an seit einigen Wochen sehr abgeschlagen zu sein

10

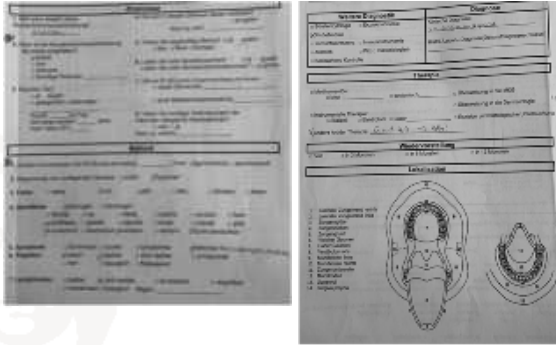
Klinische Befunde

- Extraoral: o.p.B.
- Intraoral:
 - konservierend und prothetisch versorgtes Gebiss
 - PSI auffällig
 - alle nicht WKB Zähne Sensibilität +, Perkussion -
 - Gingivawucherung imponierte als derbe, nicht gerötete Schwellung insb. im Seitenzahnbereich des OK und UK sowie palatinal und lingual im Frontzahnbereich



11

Mundschleimhaut Befund



12

Parodontologische Befunde

- erhöhte Sondierungstiefen
 - durchschnittlich 7-8mm
 - maximal 11mm
- BOP 65%
- Furkationsgrad I an 17, 16, 26, 37 und 47
- Furkationsgrad II an 17, 16 und 47
- Lockerungsgrad I an 41 und 42



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

13

Radiologische Befunde



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

14

Weiteres Procedere

- Differenzialblutbild beim Hausarzt unter dem Verdacht einer hämatologischen Erkrankung
- Ergebnis des Differenzialblutbilds: akute myeloische Leukämie (AML)
- Patient bei Nachkontrolltermin (14 Tage später) bereits in der Hämatologie/Oncologie des Universitätsklinikums Frankfurt eingebunden
- Knochenmarksbiopsie
- CTx unter stationären Bedingungen
- bereits nach erstem CTx Zyklus klinisch verifizierbare Regression der manifesten Gingivawucherung beziehungsweise der leukämischen Zellinfiltration
- WICHTIG: ORALE FRÜHSYMPTOME ERKENNEN**

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

15

Exkurs AML

- Akute Leukämien umfassen maligne Neoplasien der lymphatischen und myeloischen Zellreihe bei denen es zur übermäßigen Proliferation unreifer, nicht funktionstüchtiger Blasten im Knochenmark kommt und zur Freisetzung ins Blut kommt.
- Allgemeinsymptome:
 - Fieberhafte Infekte, Abgeschlagenheit
 - Blutungen aus Mund- und Nasenbereich
- Diagnostik:
 - Differenzialblutbild und Blutaussch (Anämie, Neutropenie, Thrombozytopenie)
 - Knochenmarkpunktion
- Intraorale Symptome:
 - Nekrosen
 - Ulcerationen
 - Gingivawucherungen (leukämische Infiltrate)
 - Blutungen
 - Candida

Quelle: Amboss, „Medizin in der täglichen zahnärztlichen Praxis“ M. Tröltzsch, P. Kaufmann, M. Tröltzsch

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

16

Siehe auch:



Link:
<https://www.zm-online.de/artikel/2022/der-ubersene-muskel/gingivawucherung-entpuppt-sich-als-leukaemische-zellinfiltration>

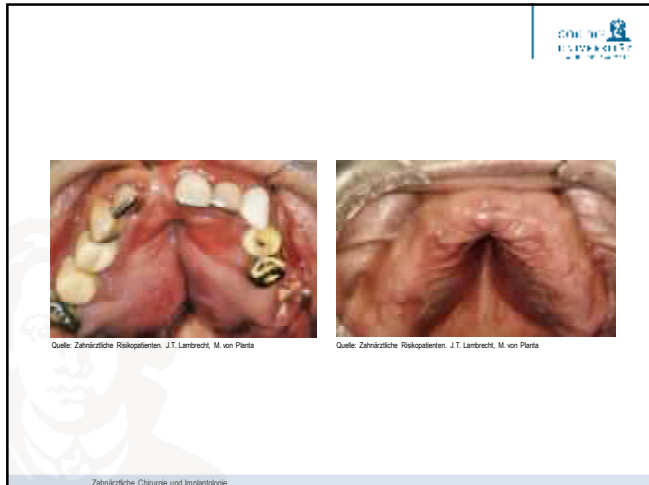
Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

17

Fallvorstellung 2

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

18



19



20

Lymphome

- Non-Hodgkin-Lymphome:
 - sehr heterogene Gruppe Erkrankungen
 - ausgehend von Zellen des lymphatischen Systems (B- und T-Zellen)
 - Lymphome werden nach Zelltyp und Malignität eingeteilt
 - niedrigmaligne Lymphome wachsen langsamer, sind aber wegen der niedrigen Teilungsrate bei systemischem Befall nur in palliativer Intention therapierbar
 - Hochmaligne Lymphome haben zwar untherapiert eine schlechtere Prognose, sind aber prinzipiell heilbar

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

21

orale Symptome von Lymphomen

- Erstmanifestation kann Schwellung im Kopf- und Halsbereich sein und einer dentogenen Abszedierung ähneln
- Klinik intraoral:
 - Weichteilschwellung insb. am Gaumen, Vestibulum, Gingiva und seltener an Wangenschleimhaut, Lippen und Mundboden
 - Später Ulzerationen
- Symptomatik:
 - Schmerzlose Weichteilschwellung zu Beginn
 - Schmerzhafte Ulzerationen
 - Zahnlockerungen bei ossärer Lokalisation
- Risiko
 - Pathologische Frakturen
 - Hyp- und Parästhesien

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

22

orale Symptome Multiples Myelom

- Erstvorstellung in Zahnklinik in Göttingen mit Schwellung am Gaumen
- Anamnese: Rückenschmerzen seit 14 Tagen
- Überweisung in Hämatologie und Onkologie, dort Diagnosestellung Multiples Myelom, stationäre Aufnahme und Therapiebeginn

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

23

Multiples Myelom

Definition: B-Zell-Klein-Kluster-Lymphom mit monoclonaler Plasmaschloßproliferation

Vorstufen einer Organmalignanz: MGUS, Smoldering Myeloma

Epidemiologie: Am häufigsten zwischen 70 und 79 Jahren, $\sigma > \rho$

Diagnostik:

- Laborparameter inkl.
 - Serumelektrophorese, Hb-Gehalt
 - Immunfixation, Serumglobulinanalyse
 - Knochenmarkpunktion
 - Ganzkörper-CT, ggf. MRT

Therapie:

- Ischämien, Knochenmetastasen von 5-8 Substanzen
- Hochdosischemotherapie + autologe Stammzelltransplantation
- Knochenstrahlung
- Erhaltung

Prognose:

- IdA: gutes Ansprechen auf Erstlinientherapie
- Häufig Rezidive innerhalb weniger Jahre
- Individuelle Einschätzung anhand R-ISS, G-Monoglobulin, LDH, Albumin, Zykloglobulin

Leitungsplan:

- Anamnese, Röntgen, Blut
- Abnorme Leukozytose, Hb-Wert, Erythrozyten
- Osteolyse:
 - Knochenmarkmetastasen
 - Spontane Frakturen
- Neurologische Symptome:
 - Algerie, Fingerringe
 - Gewichtverlust
 - Erhöhte Temperaturen / Fieber
- Ursachen und Folgen der Paraproteinämie:
 - Hyperkalzämie
 - Hyperurikämie
 - Hyperphosphatämie
 - Hyperkreatinämie
 - Hyperbilirubinämie
 - Hyperhämoglobinämie
 - Hyperhämoglobinurie
 - Hyperhämoglobinurie
 - Hyperhämoglobinurie
- Abklärung von Paraproteinämie:
 - Plasmapheresis
 - Chemotherapie
 - Plasmapheresis
- Funktionelles Antikörper-Mangeldefizit:
 - Antikörper-Mangeldefizit

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

24

Fallvorstellung 3

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

25

Erstvorstellung 31.3.25

- 14-jähriger, männlicher Patient mit Eltern vorstellig
- Allgemeinanamnese:
 - auf Anamnesebogen lediglich Aphten angegeben
 - nach ausführlicher Besprechung V.a. Leukämie → next: Arztbrief mitbringen
- Familienanamnese:
 - laut Vater hätten Brüder ähnliche MSH-Läsionen seit 6 Jahren
- Schmerzanamnese:
 - Pat berichtet über rezidivierende Gingivahyperplasie und Aphten
 - Schmerzen bei Mundhygiene

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

26

Klinische Befunde

- Extraoral:
 - o.p.B.
- Intraoral:
 - spätes Wechselgebiss
 - KIK-Klasse 3
 - Multiple harte und weiche Beläge
 - MSH generalisiert geschwollen, gerötet, UK FZ Bereich mit gestielter derber Hyperplasie
 - 33-43 Sens +, Perk –
 - 33-42 LG 1
 - 33-43 BOP +, Supp-
 - 33-43 ST bis 5mm



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

27

Radiologische Befunde



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

28

Radiologische Befunde



- Horizontaler KA 15-33%
- Verschattung i.S. Konkremente
- 32-42 PA-Spalt homogen und durchgehend

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

29

2. Termin am 02.04.25

- Arztbrief von 2016 mitgebracht
 - chronische Neutropenie
 - V.a. Autoimmunneutropenie
- Aktuelles Blutbild
- RS mit PD Dr. Andre Willasch
- Cotrimoxazoleinnahme zur Prophylaxe und Therapie von Infektionen (Samstags und Sonntags)

Ä. Anamnese	Blut	Prog	Diagnose	Therapie	Prognose
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leukopenie	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Exkurs Neutropenie

- Pathologische Verminderung der neutrophilen Granulozyten im Blut (unterhalb 0,5 - 109/l)
- Fähigkeit zur Infektabwehr ↓ und Risiko an bakteriellen Infektionen zu Erkranken ↑↑
- Pathophysiologie:
 - 2 Mechanismen die zu Neutropenie führen:
 - Verminderte Granulozytenbildung
 - Erhöhter Granulozytenverbrauch
- Ursachen:
 - Immundefekte
 - Zyklische Neutropenie
 - Kostmann-Syndrom
 - Infektionen
 - Mangelernährung
 - Medikamente
 - u.v.a.

Quelle: Amboss „Chronische Neutropenie im Kindesalter“ J. Skokowa, C. Zedler, K. Welle <https://doi.org/10.1007/s00112-018-0546-8>

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

31

Probeexzision



- Befund:
 - Polypoide plattenepitheliale Schleimhautgewebsprobe mit reaktiver Epithelhyperplasie und herdförmig Parakeratose sowie einer leichten chronischen, plasmazellreichen Entzündung
 - Kein Anhalt für Malignität

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

32

Therapieplan



- IPs (erneute MuHy Aufklärung)
- O1
- Bissflügel zur Kariesdiagnostik
- PA-Status? PA-Therapie?
- Modellierung UK FZ Weichgewebe?
- Vorstellung in KFO
- Interdisziplinäre Planung mit Kinder Hämatologie und Onkologie
- Gen Sequenzierung?

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

33

Orale Manifestationen hämatologischer Erkrankungen

- Leukämie
 - orales Frühsymptom: Gingivaschwellung, Blutungen, Ulzera
 - Subgruppen (AML, ALL, CML, CLL)
 - Fallbeispiel AML
- Multiples Myelom
 - Fallbeispiel
- Neutropenie
 - orales Frühsymptom: Erytheme, Schwellung, Infiltrate, Schmerz, Ulzerationen
 - Fallbeispiel chronische Neutropenie
- Graft-versus-Host-Disease
 - orales Frühsymptom: lichenoid Veränderungen, Hyposalivation
 - nach Stammzell- oder Knochenmarktransplantation
 - Fallbeispiel

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

34

V.a. GvHD

Symptome einer akuten GvHD (innerhalb der ersten 100 Tage post transplantationem)

- Hypersalivation (als Zeichen der Speicheldrüsendysfunktion und Schmerzen bei Nahrungsaufnahme)
- Veränderung der MSH: können OLP ähneln und stellen sich klinisch wie folgt dar. Epitheliolyse, Ulzerationen, Erythem

Diagnose? Klinisch, laborchemisch, Biopsie?

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

35

V.a. GvHD (Graft-versus-Host-Disease)



Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

36

Bei Verdacht einer Mundschleimhautveränderung

1. Aktualisierung der Anamnese
2. Ausfüllen des Mundschleimhautbogens (ggf. Mundschleimhautkontrollbogens)
3. Fotodokumentation
4. Aufklärung für eine Inzisions- oder Exzisionsbiopsie
5. Inzisions- oder Exzisionsbiopsie
6. ODER Exfoliativzytologie
7. Kontrollintervall festlegen

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

37

Was sollte auffallen?

- Lokalisation/ Ausdehnung
- Form/ Farbe/ Konsistenz
- Oberfläche/ Textur
- Abwischbar/ nicht abwischbar
- Verschieblichkeit
- Blutung/ Schmerzen
- Farbveränderungen
- Volumenveränderungen

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

38

Mundschleimhautbogen

Untersuchung der Mundschleimhaut:

1. Größe (Symmetrie und Proportion) ... ☐ normal ☐ vergrößert ☐ verkleinert
2. Begrenzung (gut abgegrenzt/ schlecht) ... ☐ gut ☐ schlecht
3. Farbe ... ☐ normal ☐ weiß ☐ gelb ☐ rot ☐ violett ☐ blau
4. Oberfläche ... ☐ glatt ☐ gerunzelt ☐ erhaben ☐ eingesenkt ☐ knotig ☐ wulstig ☐ flach
5. Konsistenz ... ☐ weich ☐ fest ☐ hart ☐ knorpelig ☐ steif
6. Symptomatik ... ☐ schmerzlos ☐ schmerzhaft ☐ juckend ☐ brennend ☐ blutend ☐ blutend
7. Begrenzung ... ☐ gut ☐ schlecht ☐ unklar ☐ diffus ☐ lokalisiert
8. Exfoliativ ... ☐ positiv ☐ negativ ☐ unklar ☐ diffus ☐ lokalisiert
9. Kontrollintervall ... ☐ 3 Monate ☐ 6 Monate ☐ 1 Jahr ☐ 2 Jahre ☐ 3 Jahre ☐ 4 Jahre ☐ 5 Jahre ☐ 6 Jahre ☐ 7 Jahre ☐ 8 Jahre ☐ 9 Jahre ☐ 10 Jahre

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

39

Allgemeine Anamnese

Anamnesebogen		Fragebogen	Beobachtung
Patientenname: _____		Fragebogen	Beobachtung
Geburtsdatum: _____		Fragebogen	Beobachtung
Klinische Untersuchung:		Fragebogen	Beobachtung
Haut und Schleimhäute:		Fragebogen	Beobachtung
Mund und Rachenraum:		Fragebogen	Beobachtung
Nase und Sinus:		Fragebogen	Beobachtung
Hals und Schilddrüse:		Fragebogen	Beobachtung
Brust und Lunge:		Fragebogen	Beobachtung
Bauch und Verdauung:		Fragebogen	Beobachtung
Genitalien:		Fragebogen	Beobachtung
Neurologie:		Fragebogen	Beobachtung
Psychiatrie:		Fragebogen	Beobachtung
Sonstige:		Fragebogen	Beobachtung

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

40

Take Home Points

- hämatologische und lymphatische Erkrankungen zeigen oft Frühsymptome intraoral wie Gingivashwelligkeit, Blutungen, Ulzera
- Zahnarztpraxis ist oft die erste Anlaufstelle
- SOP - Standard Operating Procedure → standardisierte Vorgehensweise in der Befundung und Diagnostik → AA, SA, MSH-Bogen
- Frühe interdisziplinäre Abklärung

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

41

Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

a.begic@med.uni-frankfurt.de
liersch@med.uni-frankfurt.de

Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

42